

Université de Sousse
Faculté de Médecine Ibn Aljazzar
2025



PRÉPARATION DU CONCOURS D'ACCÈS AU TCEM

Discipline : Gynécologie Obstétrique

53. Diagnostic des Métrorragies

Pr Lassoued Latifa

Département de Santé Communautaire A- FMSo
Service de Gynécologie Obstétrique
CHU Hôpital Farhat Hached- Sousse

OBJECTIFS :

1. Définir les métrorragies.
2. Expliquer les mécanismes des métrorragies fonctionnelles
3. Etablir à partir des données cliniques et para cliniques, les diagnostics étiologiques des métrorragies selon le terrain en dehors de la grossesse.
4. Etablir la démarche du diagnostic étiologique des métrorragies au cours de la grossesse, du travail et du post-partum.
5. Identifier les éléments de gravité d'une métrorragie.
6. Indiquer les premiers gestes d'urgence devant une métrorragie grave

INTRODUCTION : 1 CAS CLINIQUE... plusieurs objectifs

Une patiente de 44 ans, G2P2, vous consulte à J22 de son cycle habituellement régulier (28j/6j) pour des règles abondantes douloureuses qui se sont prolongées jusqu'au jour de sa consultation.

CC-1. La plainte de la patiente correspond à

- A. Des polyménorrhées
- B. Des ménorragies
- C. Des métrorragies
- D. Des ménometrorragies
- E. Des spanioménorrhées

CC-2. A l'examen clinique la patiente est pâle avec une TA :100/60 mmHg, pouls : 88b/min, un saignement actif d'origine endo-utérine. Outre l'examen clinique, quels exploration -parmi les suivants- préconisez-vous en priorité?

- A. Une coelioscopie
- B. Une hystérographie
- C. Une échographie pelvienne
- D. Le dosage qualitatif de BhCG
- E. Une NFS

CC-3. Il peut s'agir : L'apparition de telles anomalies chez cette patiente vous fait évoquer :

- A. D'une adénomyose
- B. D'un fibrome utérin
- C. D'un kyste dermoïde de l'ovaire
- D. D'une dysovulation
- E. D'une grossesse compliquée

I. Définir les métrorragies.

1. Les métrorragies sont :

- A. Une augmentation des règles en durée.
- B. Des règles abondantes et noirâtres.
- C. Des règles anormalement espacées.
- D. Un raccourcissement des cycles menstruels.
- E. Un saignement génital entre les menstruations

2. Les métrorragies

- A. Sont d'abondance variable
- B. Proviennent de la cavité utérine
- C. Peuvent provenir de l'exocol
- D. Surviennent entre les menstruations
- E. Sont souvent fonctionnelles en péri ménopause

3. On appelle ménométrorragies toute hémorragie génitale

- A. Abondante
- B. Avant la puberté
- C. Au cours et en dehors des règles
- D. Pendant la grossesse
- E. Après la ménopause

4. Madame Samia, 43 ans ayant un cycle régulier d'environ 30j avec des règles qui durent habituellement 5j, consulte pour saignement abondant d'origine endo-utérine survenant 23 jours après la fin de ses menstruations. Il s'agit de :

- A. Polyménorrhée
- B. Spanioménorrhée
- C. Ménorragie
- D. Métrorragie
- E. Ménométrorragie

II. Expliquer les mécanismes des métrorragies fonctionnelles

5. Les métrorragies fonctionnelles en période péri pubertaire :

- A. N'ont pas de substratum histopathologique
- B. Sont due à une hyperprogestéronémie relative
- C. Sont secondaire à une altération de l'endomètre.
- D. Peuvent être dues à une dysovulation
- E. Il s'agit d'un diagnostic d'élimination

6. Mlle Fadia âgée de 33ans, ayant un cycle régulier de 33j/6j consulte pour un saignement minime du 17^{ème} au 19^{ème} jour du cycle qui se sont répétés les 4 derniers cycles. L'examen clinique est normal. Il s'agit de
- A. Métrorragies
 - B. Infection génitale haute
 - C. Hémorragies génitales fonctionnelles
 - D. Saignement génital de l'ovulation
 - E. Un diagnostic d'élimination
7. Les saignements génitaux brunâtres survenant en fin de phase lutéale avant les règles proprement dites,
- A. Sont dus à une dysovulation ou anovulation
 - B. Sont secondaire à une hyperoestrogénie relative
 - C. Surviennent exclusivement en péri ménopause
 - D. Sont le témoin d'une insuffisance lutéale
 - E. Ne nécessite aucun traitement.

III. Etablir à partir des données cliniques et para cliniques, les diagnostics étiologiques des métrorragies selon le terrain en dehors de la grossesse.

8. Mlle Rym, 15 ans, consulte accompagnée de sa mère pour la survenu de saignement abondant pendant les règles et se prolongeant après celles-ci selon ses dires. Parmi les affections suivantes, lesquelles peuvent être responsables de ces anomalies ?
- A. Une anovulation
 - B. Une grossesse compliquée
 - C. Un Kyste dermoïde
 - D. Maladie de Willebrand.
 - E. Tumeur sécrétante de l'ovaire.
9. Parmi les suivantes, quelle est la cause la plus fréquente d'hémorragie génitale chez les adolescentes ?
- A. Un adénocarcinome vaginal.
 - B. Un corps étranger vaginal.
 - C. Une endométriose.
 - D. Une hémopathie bénigne.
 - E. Une insuffisance lutéale

10. Madame Asma, 24 ans, vous consulte pour un saignement génital récent et actif qu'elle trouve inhabituel. Votre prise en charge initiale consiste à :

- A. Vérifier la date des dernières règles
- B. Faire un examen au spéculum
- C. Réaliser un frottis cervico-utérin (FCU)
- D. Eviter de faire un toucher vaginal car contraindiqué devant tout saignement génital
- E. Réaliser une échographie pelvienne

Cas Clinique 1 (intégré)

Aicha, âgée de 14 ans vous consulte pour un saignements génital abondant inhabituel. Son examen clinique et l'échographie pelvienne sont sans particularité.

11. Quelles sont les causes possibles de ce saignement chez cette patiente ?

- A. Anovulation,
- B. Prise d'hormones stéroïdes
- C. Thrombopathies
- D. Tumeur sécrétante de l'ovaire
- E. Vaginite

12. Quels examens complémentaires -parmi les suivants- demandez-vous en première intention ?

- A. BHCG
- B. NFS
- C. Taux de plaquettes
- D. Taux d'Estradiol sanguin
- E. Etude bactériologique de prélèvement vaginal

13. Parmi les suivants, quels autres tests demanderiez-vous ensuite ?

- A. TP
- B. TCA
- C. Facteur de Willebrand,
- D. Ristocetin cofactor activity
- E. TSH et FT3

Elle est amenée aux urgences une semaine plus tard. Ses vêtements sont maculés de sang. Elle est consciente, sa PA= 90/50 mmHg, son pouls : 110b/min, RR : 16cycles/min, T° : 36°C. L'examen trouve un saignement génital fait de caillots. Son taux d'hémoglobine est de 7,5g/dl et le dosage sanguin des BhCG est négatif.

14. La prise en charge immédiate de votre patiente comprendra

- A. Un traitement en ambulatoire
- B. La prescription d'Œstrogènes conjugués
- C. L'administration d'acide tranexamique
- D. Une transfusion de sang phénotypés
- E. Une IRM pelvienne après maîtrise du saignement

15. Une patiente âgée de 32 ans vous consulte pour des saignements génitaux survenant en dehors de ses règles. Parmi les suivantes, quelles sont les causes structurelles possibles de cette symptomatologie ?

- A. Un cancer du col de l'utérus.
- B. Une insuffisance lutéale
- C. Un leiomyome utérin type 5 de FIGO.
- D. Un polype accouché par le col
- E. Un stérilet.

16. Une patiente âgée de 36 ans sans antécédents notables, vous consulte pour des saignements inter menstruels évoluant depuis trois mois, Parmi les suivantes, quelles sont les causes iatrogènes possibles de ces saignements ?

- A. Un arrêt prématuré de pilule
- B. Un traitement progestatif responsable d'une hypertrophie endométriale
- C. Un traitement hormonal de la ménopause oestrogénique mal contrebalancé par les progestatifs
- D. Un traitement anticoagulant
- E. Une endométrite

17. Les métrorragies prémenstruelles correspondent à un saignement

- A. Peu abondant
- B. Rouge vif
- C. Durant 2 ou 3 jours avant les règles
- D. Causé par une insuffisance lutéale
- E. Doit être traité par des œstrogènes J0 → J10 du cycle

18. Devant des métrorragies survenant chez une femme de 38 ans porteuse d'un stérilet, quel est -parmi les suivants- le diagnostic à évoquer en premier lieu?

- A. Un avortement spontané
- B. Un cancer du col utérin
- C. Un fibrome utérin sous muqueux
- D. Une grossesse extra-utérine
- E. Une salpingite

Cas Clinique 2 (intégré)

Mme Leila, âgée de 34 ans vous consulte pour des saignements inhabituels de faible abondance évoluant depuis 3j survenus à J10 de son cycle qui est habituellement régulier.

19. A quelle proposition parmi les suivantes correspond la plainte de la patiente ?

- A. Des macroménorrhées
- B. Des polyménorrhées
- C. Des ménorragies
- D. Des métrorragies
- E. Des ménométrorragies

20. Quel diagnostic vous devriez rechercher en 1^{er} lieu ?

- F. Un cancer du col
- G. Un cancer de l'endomètre
- H. Une infection génitale haute
- I. Une grossesse compliquée
- J. Une lésion traumatique du vagin

21. Outre l'examen clinique, quel examen -parmi les suivants- préconisez-vous en priorité pour confirmer le diagnostic suspecté ?

- F. Un FCU
- G. Une échographie pelvienne
- H. Un dosage de CRP
- I. BhCG
- J. Une NFS

22. Mme Salwa âgée de 55 ans, ménopausée depuis 6 ans, consulte pour un saignement génital. Quels sont, parmi les suivants, les diagnostics envisageables ?

- A. Une atrophie endométriale
- B. Une endométriose externe
- C. Une hyperplasie de l'endomètre
- D. Un sarcome utérin
- E. Une tumeur de l'ovaire.

23. Des métrorragies chez une femme ménopausée de 72 ans évoquent en premier lieu :

- A. Une adénomyose
- B. Une prise intempestive d'hormones.
- C. Un cancer de l'endomètre.
- D. Un cancer du col.
- E. Une atrophie vaginale.

24. Quel est, parmi les suivants, l'examen qui permet de confirmer le diagnostic de cancer de l'endomètre ?

- A. Un endomètre épais et irrégulier à l'échographie transvaginale
- B. Une hystéroscopie diagnostique montrant une lésion bourgeonnante endo utérine
- C. L'hystérosonographie montrant une formation endo-utérine hyperéchogène
- D. L'examen anatomopathologique d'une biopsie de l'endomètre
- E. L'IRM montrant un envahissement myométrial.

IV. Etablir la démarche du diagnostic étiologique des métrorragies au cours de la grossesse, du travail et du post-partum.

- 25. Mme Samia, primigeste, enceinte à 8 semaines d'aménorrhée (SA), consulte pour un saignement génital. Il peut s'agir d' :**
- A. Un cancer du col utérin
 - B. Une insertion basse du placenta
 - C. Une grossesse molaire
 - D. Une menace d'avortement spontané
 - E. Un polype cervical
- 26. Mme Syrine, âgée de 28 ans, G3P2A0, vous consulte aux urgences pour douleurs pelviennes et saignement vaginal de plus en plus abondant. A l'examen : pas de fièvre, sensibilité sus-pubienne sans défense. Son col est ouvert à 2 cm avec des caillots sanguins et du tissu au niveau de l'orifice externe. L'utérus est sensible. Pas de masse annexielle palpable. Parmi les suivants, quel est le diagnostic le plus probable ?**
- A. Une grossesse arrêtée
 - B. Une perforation utérine
 - C. Un avortement incomplet
 - D. Une menace d'avortement
 - E. Une endométrite post abortive
- 27. Chez une patiente enceinte au troisième trimestre qui consulte aux urgences pour des métrorragies :**
- A. La prévention de l'iso-immunisation rhésus si femme rhésus négatif est systématique
 - B. Un toucher vaginal permet d'éliminer un placenta prévia
 - C. Un décollement marginal du placenta est à éliminer en premier lieu
 - D. L'échographie pelvienne est le premier examen à demander
 - E. Les lésions cervicales sont parmi les diagnostics à évoquer
- 28. La cause la plus fréquente de l'hémorragie de la délivrance est**
- A. La rupture utérine
 - B. L'atonie utérine
 - C. Les lacérations cervicales
 - D. Les retentions placentaires
 - E. Les plaies vaginales

- 29. Suite à une direction prolongée du travail, Mme Saida, 25 ans, G1P0, a accouché à 42 SA d'un nouveau-né de 4.5 kg par forceps. Après la délivrance du placenta, la patiente a développé une HPP secondaire à une atonie utérine. Parmi les suivants quels sont les facteurs de risque de l'atonie utérine?**
- A. L'accouchement par forceps
 - B. La grossesse prolongée
 - C. L'induction du travail
 - D. La macrosomie
 - E. Le travail prolongé
- 30. Parmi les suivants quels sont les facteurs prédisposants aux lacérations de la filière génitale?**
- A. L'accouchement par forceps
 - B. Les efforts expulsifs à dilatation incomplète
 - C. L'accouchement de macrosome
 - D. L'accouchement rapide
 - E. La rupture prématurée des membranes
- 31. Parmi les suivants quels sont les facteurs prédisposants à la rétention de tissu placentaire ?**
- A. Leimyomes utérins
 - B. Antécédent d'accouchement par césarienne
 - C. Antécédent de curetage utérin
 - D. Grossesse multiple
 - E. Un lobe surnuméraire du placenta
- 32. Chez une femme enceinte qui saigne au 3^{ème} trimestre, quels sont les signes cliniques en faveur d'un placenta preavia ?**
- A. Saignement spontané rouge vif
 - B. Saignements accompagnés de douleurs abdominales.
 - C. Saignement d'abondance variable, volontiers récidivant
 - D. Utérus tendu hypertonique.
 - E. Bruits du cœur fœtal clairement perçus.
- 33. Toutes ces étiologies peuvent donner une hémorragie génitale externe en fin de grossesse, SAUF UNE, laquelle :**
- A. Insertion basse du placenta.
 - B. HRP.
 - C. Polype endocervical décidualisé.
 - D. Nécrose de fibrome pédiculé sous séreux.
 - E. Rupture d'un utérus cicatriciel.

Cas Clinique 3

Mme Hajer âgée de 20 ans, G4P3A0, a accouché par voie basse d'un nouveau-né de sexe masculin, Apgar 9/10/10, Poids de naissance à 4Kg300. Elle a eu un antécédent d'hémorragie du post partum dans une grossesse antérieure nécessitant une triple ligature artérielle.

Sa grossesse actuelle est compliquée de diabète gestationnel sous régime.

Le travail était dirigé par de l'ocytocine suite à une rupture prématurée des membranes compliquée de chorioamniotite. Elle a accouché rapidement et l'examen du délivre était normal

Lors de la surveillance du post partum immédiat, la sage-femme vous signale la présence d'un saignement d'origine endo utérin.

34. L'hémorragie de la délivrance est définie -dans ce cas- par une perte sanguine supérieure à quel volume ?

- A. 250 cc
- B. 500 cc
- C. 750 cc
- D. 1000 cc
- E. 1250 cc

35. Les facteurs de risque d'une hémorragie du post partum immédiat chez cette patiente sont :

- A. Un accouchement par voie basse
- B. Un antécédent d'hémorragie du post partum
- C. Un travail rapide dirigé
- D. La macrosomie fœtale
- E. La chorioamniotite

36. L'hémorragie du post partum immédiat a été retenue, quelle est l'étiologie la plus probable ?

- A. Une atonie utérine
- B. Une anomalie d'insertion placentaire
- C. La rétention placentaire
- D. La rupture d'un vaisseau aberrant intra utérin
- E. Une déchirure génitale

37. La prise en charge initiale comporte :

- A. Une hystérectomie d'hémostase
- B. Une triple ligature artérielle
- C. L'administration d'ocytocine
- D. L'examen attentif et rapide de la filière génitale
- E. Une révision utérine

38. Parmi les suivants quels sont les traitements d'une atonie utérine persistante ?

- A. Le massage utérin
- B. La ligature des artères utérines
- C. La ligature des artères hypogastriques
- D. L'hystérectomie
- E. L'embolisation artérielle sélective

Cas Clinique 2

Mme Kmar âgée de 23 ans, P2A2, GS : A négatif, vous consultez aux urgences pour douleurs pelviennes avec métrorragies. Elle vous rapporte une aménorrhée de 7 semaines. Le dosage des BHCG est revenu positif.

- 39. Quels sont les éléments de l'examen physique à vérifier en premier lieu chez cette patiente pour évaluer la gravité du saignement ?**
- A. La température
 - B. La tension artérielle
 - C. Le pouls artériel
 - D. L'examen au spéculum
 - E. Le toucher rectal
- 40. L'échographie pelvienne montrant un utérus augmenté de taille par rapport au terme, occupé par une masse hétérogène, floconneuse, contenant de multiples petites vésicules et le taux de BHCG $>10^3$ évoquent en premier lieu :**
- A. Un avortement incomplet
 - B. Une grossesse arrêtée
 - C. Une grossesse extra utérine
 - D. Une grossesse molaire
 - E. Une grossesse jeune avec un fibrome intra cavitaires remanié
- 41. La prise en charge de la patiente comporte :**
- A. Son hospitalisation
 - B. Une surveillance échographique jusqu'à disparition de la masse endo utérine
 - C. Une aspiration échoguidée
 - D. Un traitement médical au Méthotrexate
 - E. Une injection d'Anti D dans la semaine suivant le saignement

V. Identifier les éléments de gravité d'une métrorragie.

- 42. Quels sont -parmi les suivants- les éléments à chercher par l'interrogatoire en faveur de métrorragies graves ?**
- A. Les troubles connus de la coagulation
 - B. Un nombre de 8 à 10 protections utilisées par cycle
 - C. Les protections utilisées sont trempées
 - D. Traitement anticoagulant ou anti-agrégant plaquettaire en cours
 - E. Une sensation de soif
- 43. Les signes de gravité des métrorragies sont :**
- A. Une pâleur cutanéomuqueuse
 - B. Une tachycardie
 - C. Un saignement noirâtre
 - D. La présence de caillots
 - E. La survenue concomitante d'épistaxis

IV. Indiquer les premiers gestes d'urgence devant une métrorragie grave

44. Devant des signes de gravité d'une métrorragie :

- A. L'hospitalisation s'impose
- B. Un remplissage vasculaire est indispensable
- C. Un geste chirurgical doit être réalisé en urgence
- D. Un traitement ambulatoire par de l'acide tranexamique est indiqué
- E. Des oestroprogestatifs peuvent constituer un traitement de première intention

Bon travail ☺